

44. 피로

- **중요 포인트**
 - 원인 질환이 따로 없는 일과성 피로, 만성 피로 증후군이 자주 출제
 - 교육 부분 매우 중요
 - 수면의 질 저하는 어떤 질환이든 동반될 수 있으니 조금이라도 있는 것 같으면 교육에서 말하면 좋을 듯 하다
- **평가 목표**

원인				
일과성 원인	정신질환		우울증 등	
	신체질환		갑상선기능저하증 등	
만성 피로	약물		항우울제	
	원인 불명		만성 피로 증후군	
평가목표				
1) 병력청취와 신체진찰로 피로의 원인을 감별할 수 있는지				
2) 필요한 환자 교육을 시행할 수 있는지				
3) 적절한 진단 및 치료 계획을 수립할 수 있는지				
구체적인 성과				
병력 청취	피로의 중요 특성 평가		기간(6 개월 이상인지), 양상, 정도, 휴식시 나아지는지	
	피로를 유발하는 질환의 동반증상 평가		갑상샘기능저하증(추위불내성/체중감소/피부 푸석), 폐암(체중감소/장기 이상 증상) 폐결핵(기침/가래/야간발한/발열), 애디슨병(색소침착/메스꺼움), 율혈심부전 (호흡곤란/오목부종)	
	위험 요인 평가		스트레스, 술/담배/커피, 수면의 질, 기저질환, 식습관, 우울감	
신체 진찰	원인질환 감별		-	
진단 및 치료	원인 질환 감별	일과성피로	-	휴식, 생활습관 개선
		만성피로증후군	기질적 원인 배제 -> 심초음파, CXR, PET/CT 등?	생활습관 개선, 인지행동 치료, 약물치료 (수면제, 항우울제)
		갑상샘기능저하증	갑상선 기능 검사	약물치료(갑상샘호르몬 보충제)
		폐결핵	객담 항산균 도말 TB-PCR	항결핵제
		암	PET/CT	수술, 항암치료, 방사선
환자 교육	피로의 원인에 따라 필요한 사항 교육		금연/금주, 카페인줄이기, 규칙적 운동, 수면위생	

● 원인 질환 정리

질환		질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
생리적	일과성 피로 2+1	과도한 업무나 스트레스 후 발생하며, 휴식 시 바로 호전되는 정상적인 반응	사회력 중요 피로 외 다른 증상 X 휴식에 의한 완화	-	-	휴식, 안심시키기
	만성 피로 증후군 2+1	원인 질환 없이 6 개월 이상 일상생활이 불가능할 정도의 극심한 피로가 지속되는 배제 진단 질환	8 가지 진단 기준-전신 근육통, 다발성 관절통, 인후통, 운동 후 권태감, 6 개월 이상 지속, 기억력/집중력 저하, 잠자도 피곤, 림프절 압통,	-	다른 검사 후 배제 진단	생활습관 교정 , 인지 행동 치료 항우울제
내분비	애디슨병	(일차성 부신기능 저하증)코티솔/알도스테론 결핍으로 인해 피로, 색소침착	메스꺼움, 구토, 체중감소, 색소 침착	입 점막 주위 착색	혈액검사(혈중 코티솔, ACTH 농도)	약물치료(hydrocortisone, prednisolone)
	갑상샘저하증	갑상선 기능 저하로 인해 대사가 느려지는 질환	추위불내성, 변비, 체중증가, 피부 푸석	갑상샘 종대	혈액검사(갑상샘 기능검사)	levothyrosine
종양	암	암세포가 몸의 영양분을 다 뺏아가서 이유 없이 살이 빠지고 기운이 하나도 없는 소모성 상태	체중감소, 장기 이상 증상		혈액검사(Tumor marker) PET/CT	수술 항암치료 방사선
호흡기	폐결핵	결핵균 감염으로 폐가 손상을 입어서 몸이 균이랑 싸우느라 항상 피곤	발열, 기침, 객혈, 체중감소, 야간발한 , 결핵 Hx		객담항산염색 객담배양 CXR, CT	항결핵제
순환기	울혈 심부전	심장이 피를 못 짜줘서 폐에 물이 차고, 조금만 움직여도 숨이 차서 피곤	호흡곤란, 오목부종, 체중증가	경정맥 확장 심잡음	심초음파 심전도	이뇨제 BB ACE inhibitor
Loss	빈혈 1+1	혈액 속 산소 배달원이 부족해 뇌와 근육에 산소가 안 가서 어지럽고 피곤	호흡곤란, 어지러움 위 수술 Hx. 출혈 Hx	결막 창백	혈액검사 (CBC) 말초혈액도말검사	수분 철분제 코발라민
정신	주요 우울증	뇌의 신경전달물질 불균형으로 기분이 가라앉고 모든 일에 흥미를 잃어 몸이 천근만근인 상태	우울, 식욕 저하, 의욕 저하, 체중 감소, 불면	-	Beck 의 우울척도검사	항우울제 증상 심하면 입원
	수면장애	코골이나 불면증으로 수면의 질이 바닥나서, 낮 시간 내내 머리가 멍하고 졸음이 쏟아지는 상태	불면	-	-	수면 위생 수면다원검사 수면제

O	언제 (6 개월 지났는지) 어떤 상황 -운동이나 활동한 후에 피곤한건지
L	-
D	지속 시간) 하루 종일? 간헐적? 특정 시간대에 더 피곤? -아침에 더 피곤한건지 r/o 일과성 피로, 수면장애
Co	점점 심해지는지
Ex	이전 경험 - 치료
C	개방형: “어떤 증상을 피로하다고 하시는 건가요?” 양상) 어떻게 피로? ex) 몸에(팔다리에) 힘 없음/호흡곤란/집중력 저하/잠을 자고도 졸리나요? 정도) 일상생활에 지장 (-> 공감 PPI)
A	개방형: “다른 불편한 곳은 없으세요? 네. 그럼 제가 몇가지 자세하게 확인해보겠습니다.” [전신] 발열/오한/체중변화/피로/식욕부진 r/o 암, 결핵 [출혈] 어지러움/두근거림/호흡곤란 r/o 빈혈 [만성피로증후군] 8 가지 증상 중 4 가지 이상이 동시에 6 mo 이상 지속 + 타질환으로 원인 설명 불가 근육통/다발성 관절통/두통/인후통/경부, 액와림프절 압통 + 운동 후 권태감/기억력,집중력 장애/잠자도 피곤 -통증 5 가지 + 증상 3 가지 -다 물어볼것인지 정해야함 -운동 후 권태감 멘트 추천: 운동 후에 멍하거나 너무 기운 없진 않으세요? 암기법: 통통통통통 잠기운 (잠자도피곤/기억력,집중력/운동후권태) [수면장애] 잠은 잘 주무시나요? 몇시부터 몇시? 수면 환경에 대해(ex. 잠을 자는 곳은 충분히 조용한가요/어두운가요?, 자기전에 핸드폰 하시나요? 등) 키와 몸무게? -> 코골이?/ 낮잠 자주 주무시나요? [내분비] -갑상샘기능저하/항진증: 더위불내성/추위불내성/변비/설사/피부거칠칙 -부신기능저하증: 쿠싱증후군의 임상양상, 색소 침착(입술, 입안) [순환/호흡기] 기침/가래/부종/호흡곤란 r/o CHF, 폐결핵 [소화기] 황달/복수 r/o 만성 간염 A/N/V/C/D/P/D/J → A/P [정신] 우울/불안
F	개방형: “증상이 어떨 때 좀 괜찮아지고/심해지나요?” 스트레스 운동
E	건강검진 - 흉부 x 선 간염 예방접종
외	외상 수술 - 위절제술 받은 적? (빈혈)
과	기저질환 (HTN/DL/DM/Tb/Hep) 정신과 진료 간기능 나쁘다고 들어본적?
약	복용 중인 약물 , 스테로이드 치료 받은적 있는지
사	기본 : 음주/흡연/커피/직업/스트레스/식습관/운동 식습관- 채식하진 않는지 직업 - 스트레스나 부담 심한지/ 근무 조건이 변했는지 -해당된다면 만성 피로증후군의 진단기준에 부합하지 않는다 (일과성 피로로 ㄱㄱ) *만성 피로증후군은 현재의 힘든 일 때문에 생긴 피로가 아니어야함 운동 - 평소 활동량?/평소에 과하게 운동하진 않는지
가	비슷한 증상 기저질환 암, 결핵
여	주기, 월경과다
PEx	동의 구하기, 손 씻기 v/s 확인-눈-코-입-목-사지-폐

기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) > 나중에 수액/수혈 필요할 수 있습니다. 1 눈: 빈혈, 황달 2 입: 탈수 + 구강 시진(색깔 변화) 3 목: 경부 림프절 + 갑상샘 4 사지 : 피부 긴장도, 다리부종 5 복부 진찰 : 시-청-타-촉(간비대) 6 흉부 진찰 : 심음, 호흡음	
협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기		
진단 치료 교육	기본	충분한 휴식 + [교육] 생활습관개선 -커피 줄이기 -유산소 운동 -수면 위생 -스트레스 유발 요인 피하기 -규칙적 식습관(자기전에 음식 X)
	일과성피로	-
	만성피로증후군	기질적 원인 배제 -> 심초음파, CXR, PET/CT 등? 인지행동 치료, 약물치료 (수면제, 항우울제)
	갑상샘기능저하증	- 약물치료(갑상샘호르몬 보충제)
	폐결핵	객담 항산균 도말 TB-PCR 항결핵제
	암	PET/CT 수술, 항암치료, 방사선
	우울증	우울척도검사 항우울제
	빈혈	말초혈액도말검사 철분제, 수분 보충, 필요시 수혈
	(안심/진단검사/치료응급/회피교정/검진접종) [안심] “걱정이 많으셨을 텐데요~” 일과성 피로) “잘먹고 잘 쉬기만 해도 나으니 걱정 마세요~” [진단검사치료] -의심되는 질환 설명- 정신적 원인이라고 강조하지 말기 “의학적으로 아무 이상 소견이 나타나지 않는다고 아무 문제가 없다는 것은 아닙니다. 다른 증상이 나타나는지 지켜보는 기간이 필요합니다. 심리적인 문제일 경우 저절로 회복되는 것을 기대할 수 있습니다.” 검사: 혈액검사(를 통해 갑상샘 기능 평가, 빈혈 수치 체크) + 추가 검사(원인 질환에 따라) 치료: 충분한 휴식+ 치료(원인 질환에 따라) [회피/교정] 생활습관 교정 - 술/담배/커피 줄이기 - 유산소 운동 주 3 회 이상 (땀날 정도로) - 스트레스 유발 피하기 - 잠들기전에 음식 먹지 않기 수면위생 - 충분한 수면 시간 확보(7 시간 이상) - 편안한 수면 환경 확보(조용, 어둠, 자기전에 폰 하지 말기) 약물 남용 [검진/접종]	

PPI	궁금하신 점 있으실까요?
-----	---------------